



保健医療論 (1)

社会保障制度1

環境労働衛生学 上島通浩

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

知っているべきマクロの視点

我が国の

- 社会保障制度
- 医療提供体制
- 医療保険制度
- 医療の課題と対策

誰が(どこが)システムを構築しているか？

学習が求められる視点

- 人々の健康は**社会の仕組み**がつくる
 - 医療技術
 - 医療資源[医療資源の構成要素]
 - 医療資源の適正配置の仕組み(医療提供体制)[法]
 - 医療資源を確保するための財源[医療保険制度]
 - (文化・国民の行動)
- 医師として社会(集団)に・社会(集団)を通してアプローチする視点

憲法第25条

- すべて国民は、**健康**で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び**公衆衛生**の向上及び増進に努めなければならない

衛生行政(保健医療行政)

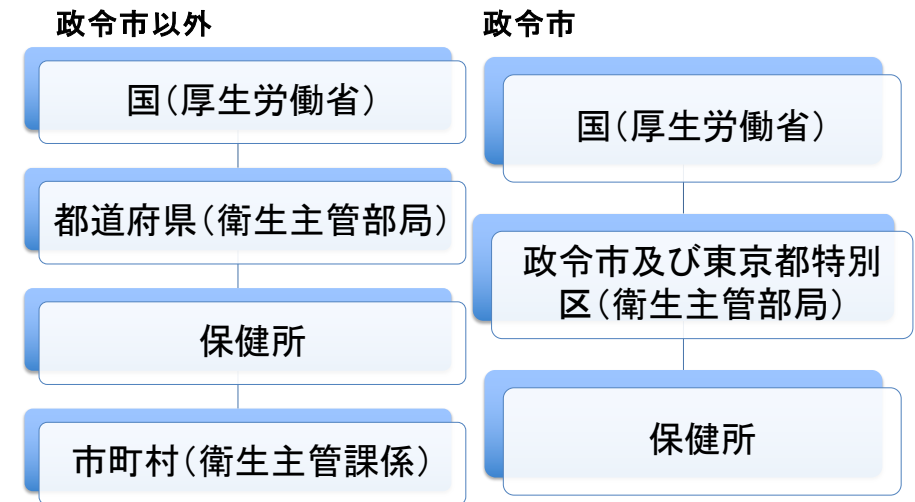
保健行政

- 一般衛生(地域保健)
 - 母子保健
 - 老人保健
 - 生活習慣病対策
 - 生活衛生・食品保健
 - 精神保健
 - 歯科保健
 - 感染症対策
 - 環境保健(環境省)
 - ⋮
- 労働衛生
- 学校保健

医療行政

- 医療
 - 医療提供施設
 - 医療従事者
 - プライマリケア
 - 救急医療
 - 周産期医療
 - へき地医療
 - 医療安全・院内感染対策
 - 災害医療
 - ⋮
- 医療保険

行政組織



知っているべきマクロの視点

我が国の

- 社会保障制度
- 医療提供体制
- 医療保険制度
- 医療の課題と対策

これらすべての背景にあるキーワードは？

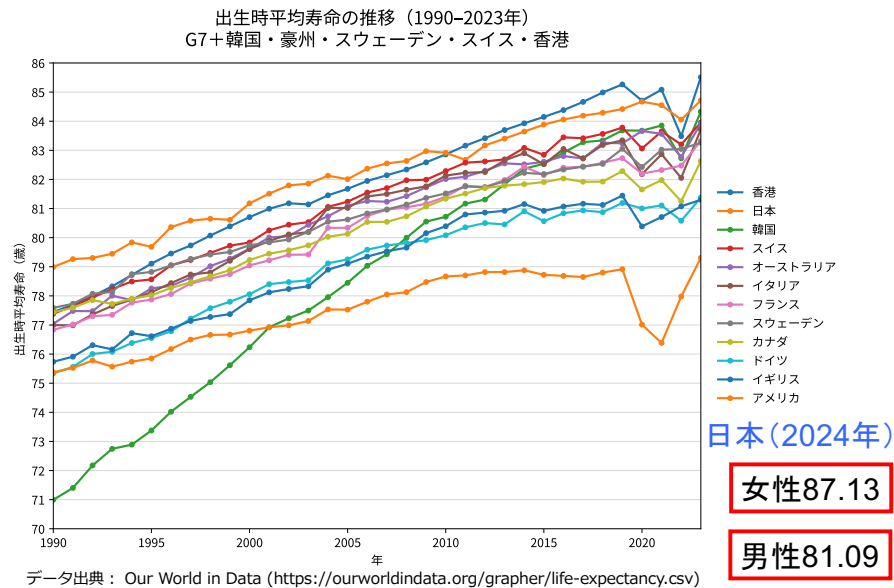
少子高齢化

1985年：65歳以上人口割合 10%
2005年：65歳以上人口割合 20%

2015年：65歳以上人口割合 26.6%
75歳以上人口割合 12.8%

2025年：65歳以上 29.4% (3,619万人)
75歳以上 17.2% (2,124万人)

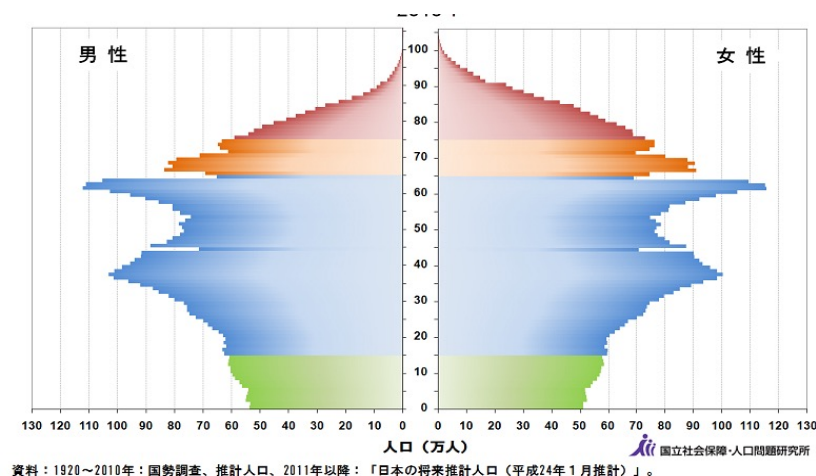
主要先進国における平均寿命の推移



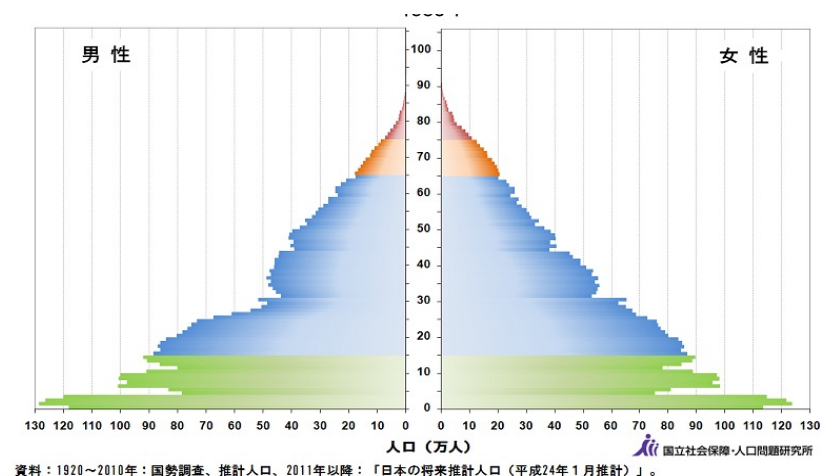
百歳以上高齢者数の推移

年次	男(人)	女(人)	計(人)	女性割合(%)	平均寿命(男)	平均寿命(女)
昭和38年	20	133	153	86.9	67.21	72.34
48年	91	404	495	81.6	70.70	76.02
58年	269	1,085	1,354	80.1	74.20	79.78
平成5年	942	3,859	4,802	80.4	76.25	82.51
10年	1,812	8,346	10,158	82.2	77.16	84.01
15年	3,159	17,402	20,561	84.6	78.36	85.33
20年	5,063	31,213	36,276	86.0	79.29	86.05
22年	5,869	38,580	44,449	86.8	79.64	86.39
24年	6,534	44,842	51,376	87.2	79.94	86.41
26年	7,586	51,234	58,820	87.1	80.50	86.83
28年	8,167	57,525	65,692	87.6		
令和2年	9,475	70,975	80,450	88.2	81.64	87.74
6年	11,161	83,958	95,119	88.6	81.09	87.13
愛知県(R6年)	448	3,201	3,649	87.7	総数7位	比率46位

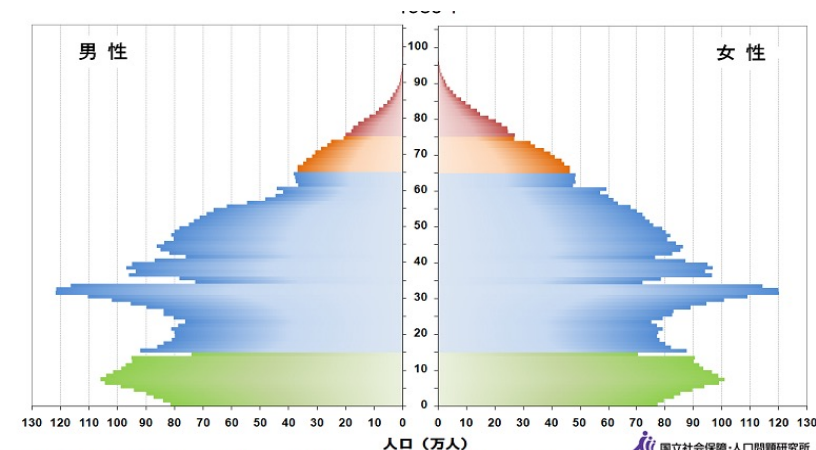
2010年の人口ピラミッド



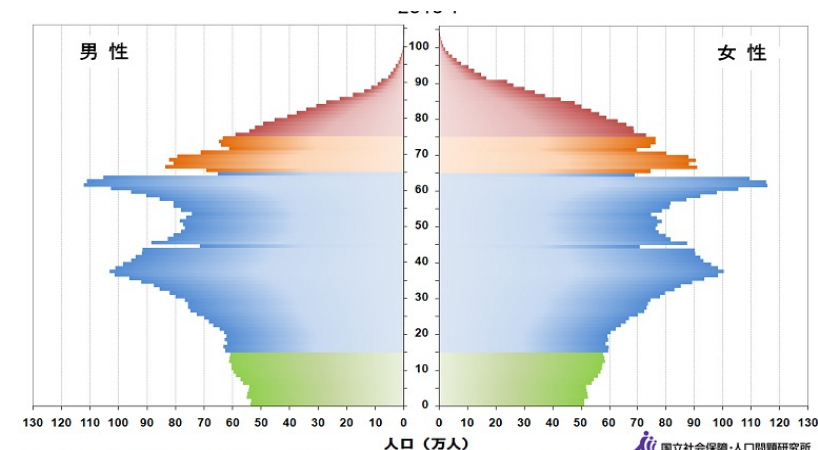
1950年の人口ピラミッド



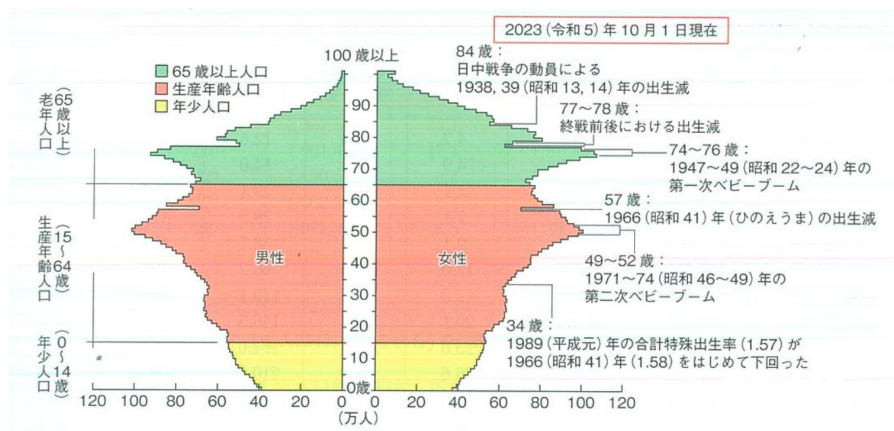
1980年の人口ピラミッド



2010年の人口ピラミッド

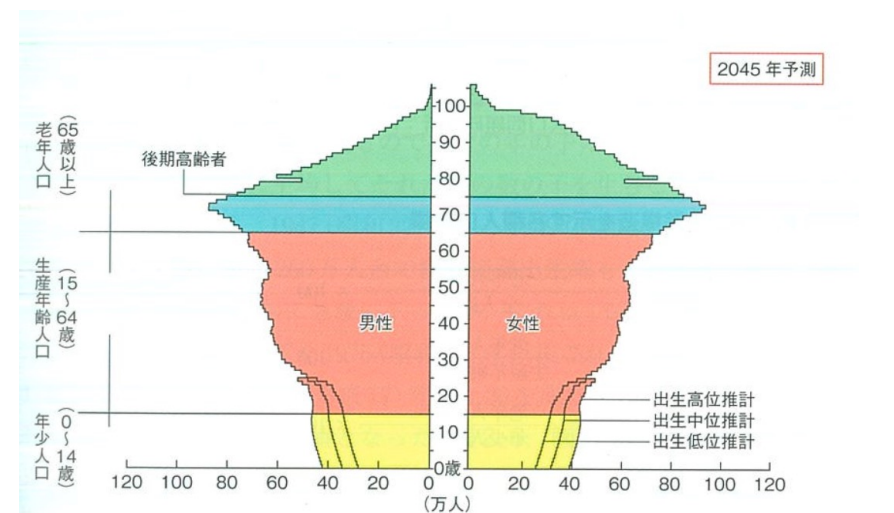


2023年の人口ピラミッド



出典：シンプル衛生公衆衛生学2025（南江堂）

2045年の人口ピラミッド



出典：シンプル衛生公衆衛生学2025（南江堂）

我が国の社会保障制度

日本国憲法第25条

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

社会保障制度とは

社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネット。
社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生からなり、人々の生活を生涯にわたって支えるものである。

① 社会保険(年金・医療・介護)

国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故(保険事故)に遭遇した場合に一定の給付を行い、その生活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度

- 病気やけがをした場合に誰もが安心して医療にかかることのできる**医療保険**
- 老齢・障害・死亡に伴う稼働所得の減少を補填し、高齢者、障害者及び遺族の生活を所得面から保障する**年金制度**
- 加齢に伴い要介護状態となった者を社会全体で支える**介護保険** など

② 社会福祉

障害者、母子家庭など社会生活をする上で様々なハンディキャップを負っている国民が、そのハンディキャップを克服して、安心して社会生活を営めるよう、公的な支援を行う制度

- 高齢者、障害者等が円滑に社会生活を営むことができるよう、在宅サービス、施設サービスを提供する**社会福祉**
- 児童の健全育成や子育てを支援する**児童福祉** など

③ 公的扶助

生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し、自立を助けようとする制度

- 健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する**生活保護制度**

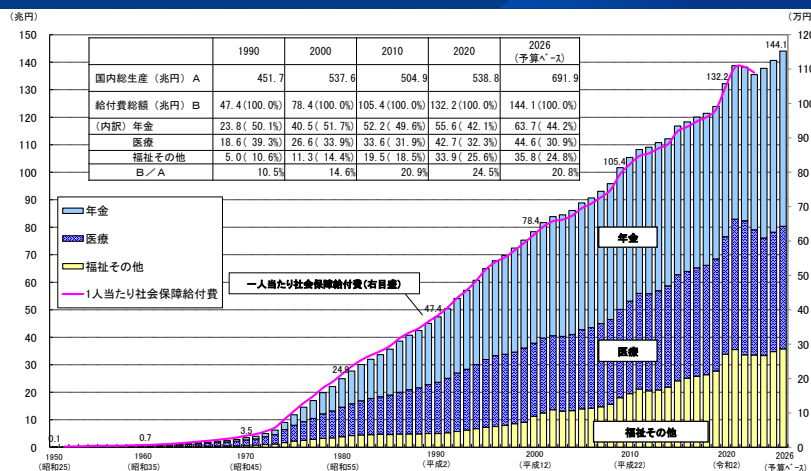
④ 保健医療・公衆衛生

国民が健康に生活できるよう様々な事項についての予防、衛生のための制度

- 医師その他の医療従事者や病院などが提供する**医療サービス**
- 疾病予防、健康づくりなどの**保健事業**
- 母性の健康を保持、増進するとともに、心身ともに健全な児童の出生と育成を増進するための**母子保健**
- 食品や医薬品の安全性を確保する**公衆衛生** など

※これらの分類については、昭和25年及び昭和37年の社会保障制度審議会の勧告に沿った分類に基づいている。

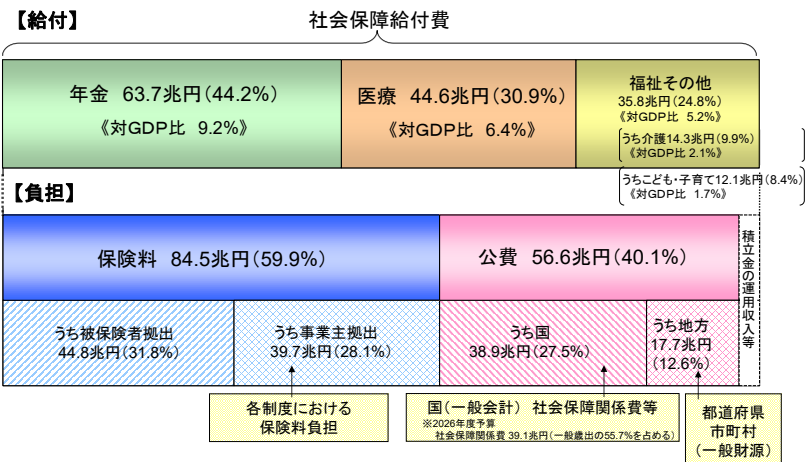
社会保障給付費の推移



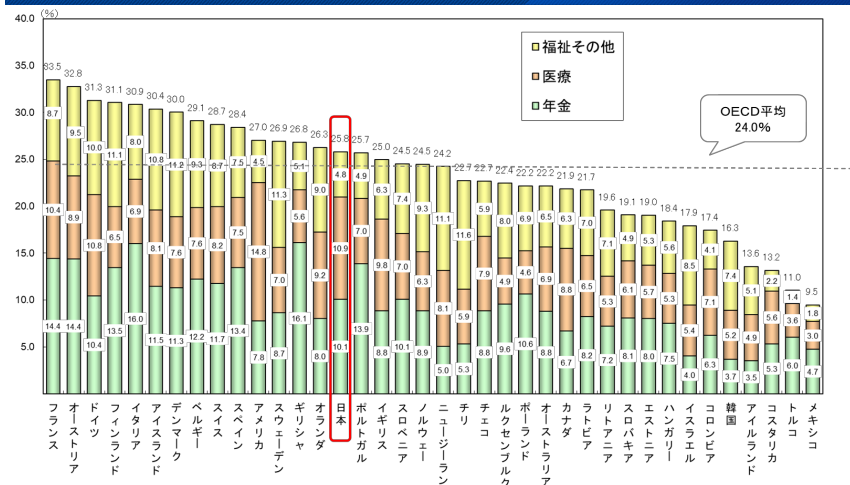
資料: 2023年度までは国立社会保障・人口問題研究所「令和6年度社会保障費用統計」、2024～2026年度(予算ベース)は厚生労働省推計。
2026年度の国内総生産は「令和8年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(令和8年1月23日閣議決定)」
(注) 図中の数値は、1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020及び2026年度(予算ベース)の社会保障給付費(兆円)である。

社会保障の給付と負担の現状(2026年度予算ベース)

社会保障給付費 2026年度(予算ベース) 144.1兆円(対GDP比 20.8%)



社会保障給付の部門別の国際的な比較（対GDP比）



(出典) OECD: "Social Expenditure Database"に基づき、厚生労働省で算出したもの(20250912閲覧)。いずれも2021年の数値。
(注) OECD社会支出データベースに基づく社会支出(データを用いているため、社会保険給付費より幅広い範囲の費用(施設整備費等)も計上されている。社会支出は、公的社會支出(Public Expenditure) + 義務的私的社會支出(Mandatory Private Expenditure)。

出典 厚生労働省HP (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21509.html?utm_source=chatgpt.com)

国民医療費

- 定義: 医療機関などにおける傷病の治療に要する費用のうち、**医療保険**及び**公費医療**によるものを推計したもの(診療費、調剤費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、看護費など)

※ 正常妊娠・分娩費用、予防接種費等は含まず

人口ひとりあたり 38.7万円

(65歳未満22万円、65歳以上80万円(国民医療費全体の6割を占める))

国民医療費48兆円(2023年度)

人口1人あたり38.7万円

対国内総生産(GDP)比8%

《制度区分別》

公費負担医療給付分 3兆円(7%)
医療保険等給付分 22兆円(45%)
うち被用者保険 12兆円
国民健康保険 9兆円
その他(労災保険等) 0.3兆円
後期高齢者医療給付分 17兆円(36%)
患者負担 6兆円(12%)

《財源別》

国庫 12兆円(25%)
地方 6兆円(13%)
保険料 24兆円(50%)
うち事業主11兆円
被保険者14兆円
その他 6兆円(12%)
うち患者負担 6兆円

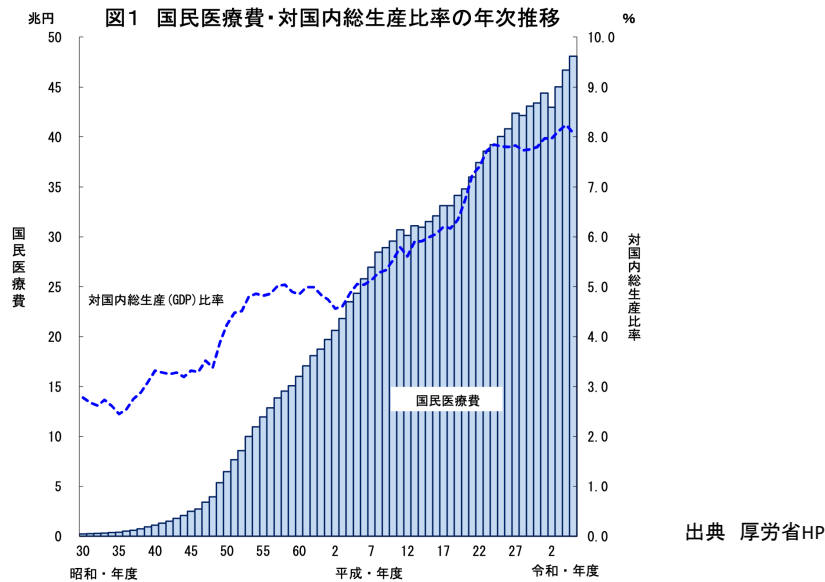
財源は「保険料が半分、公費が4割弱、患者負担が1割強」と覚える

診療種類別の国民医療費

(2023年度)

- 医科診療医療費 35兆円(72%)
 - 入院医療費18兆円
 - 入院外医療費17兆円
- 歯科診療医療費 3兆円(7%)
- 薬局調剤医療費 8兆円(18%)
- 入院時食事・生活医療費 0.7兆円(1.5%)
- 訪問看護医療費 0.6兆円(1.2%)
- 療養費等 0.5兆円(1.0%)

我が国の国民医療費の推移



我が国の医療提供体制

医療制度

1. 医事・薬事に関する制度
 - － 医療法
 - － 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)
2. 医療従事者の資格に関する制度
 - － 医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法等の各種資格法
3. 医療保険に関する制度

医師法

- 第1条 医師は、**医療**及び**保健指導**を掌ることによつて**公衆衛生の向上及び増進**に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

第9条 医師国家試験は、**臨床上必要な医学**及び**公衆衛生**に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。

第16条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。

第16条の三 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医の定員を定めるものとする。

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第17条の二 大学において医学を専攻する学生であつて、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業をすることができる。

第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2 略

第23条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

医療提供の理念

・医療法第1条の2

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は単に治療のみならず、疾病予防のための措置およびリハビリテーションを含む、良質かつ適切なものでなければならない。

医療法(医師法と区別すること)

- ・医療提供施設(医療施設)を定める
- ・医療提供施設の管理体制、人員配置基準、構造設備基準などを規定
- ・医療を提供する体制を確保するために、都道府県が医療計画を策定
 - －医療圏の設定
 - －基準病床数の設定
 - －特定の医療分野(がん、脳卒中、糖尿病、救急医療、災害医療、小児医療など)の計画
 - －医療従事者の確保
 - －医療安全の確保 など

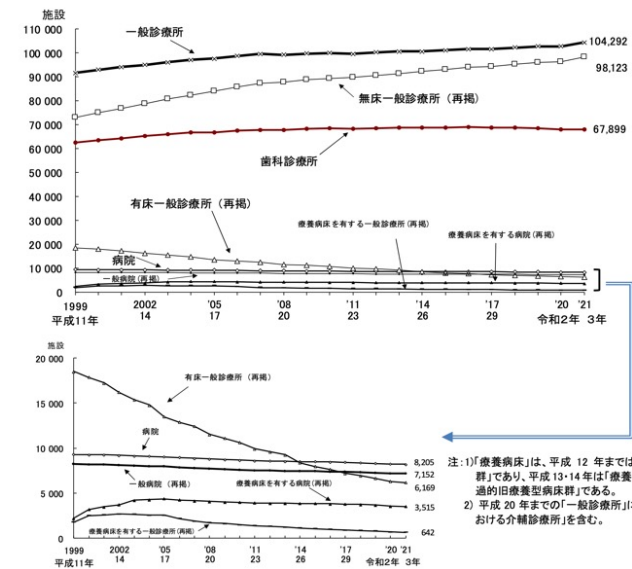
医療提供施設の種類(医療法第1条の5)

- 病院; 20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの《都道府県知事の許可》
 - ・地域医療支援病院(法第4条): 県内31病院
 - ・特定機能病院(法第4条の2): 県内4大学病院、県がんセンター
 - ・臨床研究中核病院(法第4条の3): 県内1大学病院
- 診療所; 患者を入院させる施設を有しないか、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)《届出》
- 助産所; 助産師が管理するもの。10人以上の妊婦・褥婦の収容施設を有することはできない。(法第2条)

医療施設数及び病床数 (医療施設調査 2024年)

種 類	施設数	愛知県	病床数
病 院	8,060	307	1,469,845
一 般	7,003	271	1,228,049
精神科	1,057	36	241,796
一般診療所	105,207	5,727	
有床診療所	5,415	260	72,451
歯科診療所	66,378	3,673	61
総 数	179,645	9,707	1,542,357

医療施設(病院・診療所)数の推移



出典
厚労省HP

愛知県地域保健医療計画(2024-29)

5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)、**5事業**(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)及び在宅医療の医療提供体制の構築等を記載

1. 医療圏及び基準病床数等

－ 2次医療圏は、11医療圏

－ **基準病床数**は54,401床(療養病床および一般病床)、精神病床11,508床、結核病症115床、感染症病床72床

愛知県内の2次医療圏(全部で11)

入院医療の整備を図る地域的単位



愛知県地域保健医療計画(つづき)

- 2. 保健医療施設の整備目標
 - － 2次3次医療の確保
 - － 公的病院等の役割を踏まえた医療機関相互の連携のあり方
 - － 地域医療支援病院の整備: 2次医療圏に1か所以上
 - － 保健施設の基盤整備: 保健所の機能強化
- 3. 機能を考慮した医療提供施設の整備目標
 - － がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、精神保健医療、移植医療、難病・アレルギー疾患、感染症・結核、歯科保健医療

愛知県地域保健医療計画(つづき)

- 4. 救急医療対策
- 5. 災害医療対策
- 6. 新興感染症発生・まん延時における医療対策
- 7. へき地保健医療対策
- 8. 周産期医療対策
- 9. 小児医療対策
- 10. 在宅医療対策
- 11. 保健医療従事者確保対策
- 12. その他医療提供体制の確保に関し必要な事項
 - 病診連携、高齢者保健医療福祉対策、薬局の機能強化、保健医療情報システム、医療安全対策、血液確保対策、健康危機管理対策など

主な医療関係者等の数(2024)

職 種	実 数	率(人口10万対)
医 師	347,772	280.9
歯科医師	103,652	83.7
薬 剤 師	329,045	265.8
保 健 師	63,536	
助 産 師	38,721	
看 護 師・准看護師	1,596,164	
歯科衛生士	149,579	
歯科技工士	31,733	

医師、歯科医師、薬剤師: 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計
その他の職種: 令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)

我が国の医療・介護保障制度

医療・介護を支える主な公的制度

区分	主な対象	何を保障・支援するか
公的医療保険	国民一般	病気・けがに対する診療、投薬、手術、入院等の医療費
公費負担医療制度	特定の疾患・状態・事情に該当する人	医療保険の自己負担分等を国・自治体が軽減・負担
介護保険	主に65歳以上の要支援・要介護者、または40-64歳で特定疾病による要介護者	介護サービス、介護予防、生活支援、自立支援

誰が加入するか

区分	対象	介護保険サービスを使える条件
第1号被保険者	65歳以上	原因を問わず要支援・要介護状態になった場合
第2号被保険者	40～64歳の医療保険加入者	末期がん、関節リウマチなど、加齢に伴う特定疾病が原因の場合

市町村が保険者： 保険料を集め、要介護認定を行い、介護サービスの給付を管理。住民にとっての窓口は市町村、地域包括支援センター、ケアマネジャー等

介護保険

- ・ 高齢者などが介護を必要とする状態になったときに、社会全体で費用を出し合って介護サービスを受けられるようにする公的保険制度
- ・ 高齢化、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化、核家族化、家族介護の限界が背景
- ・ 介護保険法は2000年施行
- ・ 「家族だけで支える」のではなく、「本人が必要なサービスを選びながら、社会全体で支える」仕組み

財源・保険料

- ・ 介護サービス費用=40歳以上の保険料(50%)+公費(国、都道府県、市町村:50%)+利用者自己負担
- ・ 保険料は、第1号被保険者は市町村に納める(年金から天引き)、40～64歳の第2号被保険者は、健康保険料と一緒に払う
 - 2024～2026年度の全国平均の第1号保険料は月額6,225円

サービス利用には「要介護認定」が必要

- 市町村に申請し要支援・要介護認定を受ける(主治医意見書、心身の状況に関する調査に基づき、**介護認定審査会**が認定)
 - 要支援1・2:生活機能の低下があり支援が必要。介護予防や生活支援が中心。
 - 要介護1～5:日常生活に介護が必要。数字が大きいほど介護の必要度が高い。訪問介護、通所介護、施設サービス等の利用が可能。
- 要介護度に応じて、利用者がサービスとサービス提供事業者を選択し、**ケアプラン(介護サービス計画書)**を決定
- **ケアマネジャー(介護支援専門員)**が本人や家族と話し合っ**て**ケアプランを作成すること多い

医療の課題と対策

介護サービスの種類

- 在宅サービス
 - 訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所、福祉用具貸与等
- 地域密着型サービス
 - グループホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護等
- 施設サービス
 - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

我が国の医療の課題

1. 地域医療提供体制(特に救急・周産期医療)の確保
2. 医師・看護師等の不足(偏在)
3. 医療の効率化と安全・質の確保
4. 医療費の急速な伸びの抑制
5. 高齢化の急速な進展への対応
6. 生活習慣病の増加

医師数・看護師数の国際比較 (人口千人当たり)

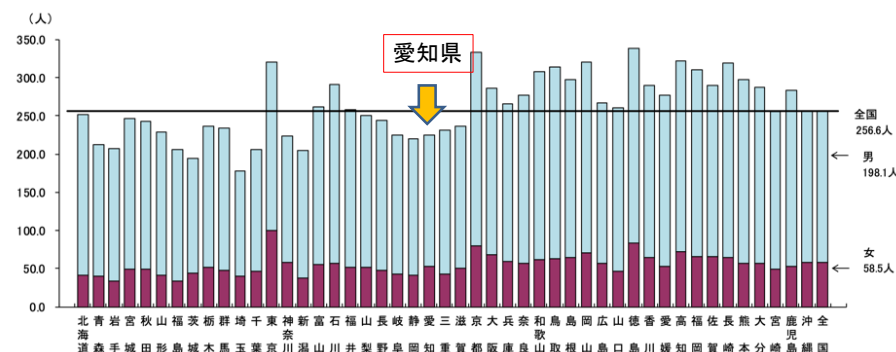
(単位:人)

	臨床医師数	看護職員数
日本	2.6	12.2
アメリカ	2.7	12.4
英国	3.4	9.1
ドイツ	4.7	12.2
フランス	3.9	8.8

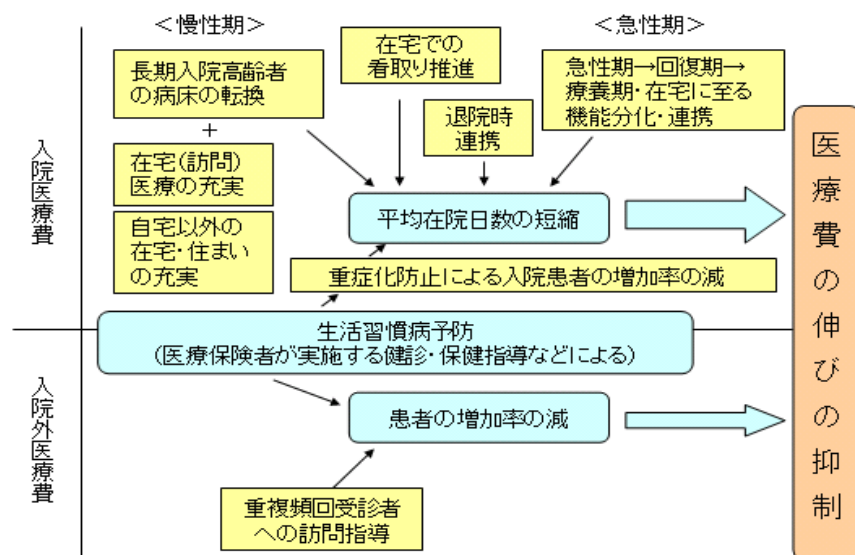
(資料:OECD Health Statistics 2025)

都道府県別医師数(地域偏在)

西高東低の傾向



いかに医療費を適正化するか



医療機関の機能分担と連携

